



# **[QST CLASSEES PAR COURS]**

## **MALADIES DE SYSTEME**

**Réalisé par : D/L**

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  
ان اصبحت فمن الله وان اخطات فمن نفسي والشيطان

Ce document constitue une version initiale d'une collection de **QROCs**, classées par cours du module **Maladies Systémiques**, issues des examens de notre faculté.

Les QST présentées couvrent les sessions allant de **2024 à 2026** avec un « **corrigé proposé** »

Nous tenons à préciser qu'il peut contenir des manques ou des erreurs ; nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.

**Remarque :** « Afin de mettre ce document à votre disposition le plus rapidement possible pour vous accompagner dans vos révisions (en cours de module comme pour les rattrapages), une relecture approfondie n'a pas pu être finalisée. Par conséquent, quelques coquilles ou fautes d'inattention peuvent subsister. Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons une excellente réussite. »

# Sommaire

**Note :** Pour les utilisateurs sur PC, vous pouvez cliquer directement sur le titre d'un cours dans le sommaire pour accéder à la page correspondante.

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PARTIE THEORIQUE .....</b>                                        | <b>5</b>  |
| • Le Lupus érythémateux systémique (LES) .....                       | 6         |
| • Le syndrome des anticorps anti-phospholipides (SAPL) .....         | 11        |
| • La maladie de Behçet .....                                         | 15        |
| • La sclérodermie systémique .....                                   | 21        |
| • Les Granulomatoses systémiques (Sarcoïdose) .....                  | 26        |
| • Le Syndrome de Gougerot-Sjögren .....                              | 28        |
| • Les maladies auto-inflammatoires (Maladie de Still) .....          | 32        |
| • Les Myopathies inflammatoires .....                                | 36        |
| • Les Amyloses .....                                                 | 40        |
| • Les vascularites systémiques .....                                 | 43        |
| • Approche diagnostique des maladies rares .....                     | 47        |
| • Les déficits immunitaires .....                                    | 50        |
| • Principes du traitement et du suivi des maladies systémiques ..... | 52        |
| <i>L'atteinte articulaire (résumé) .....</i>                         | <i>55</i> |
| <b>Partie pratique .....</b>                                         | <b>56</b> |

# PARTIE THEORIQUE

# Le Lupus érythémateux systémique (LES)

P2 2026

**1) Quel anticorps expose au risque de lupus néonatal ? que fait-il craindre chez le fœtus ?**

- AC anti SSA.
- Complication à craindre : Bloc auriculo-ventriculaire (BAV)

P1 2025

**2) Décrire l'atteinte cutanée du lupus aigu.**

- Érythème papulo-maculeux touchant les pommettes et le nez de façon symétrique et bilatérale en aile de papillon (Vespertilion)
- Peut toucher tout le visage et les zones photo-exposées
- Aspect peut être érythémateux ; maculeux ; maculeux papuleux, finement squameux
- Disparaît sans laisser de cicatrices
- Au niveau des mains : épargne les articulations
- Au niveau de la bouche : ulcérations très douloureuses sans enduit blanchâtre (contrairement aux aphtes)

**3) AC de lupus néonatal et la complication à craindre**

- AC anti SSA.
- Complication à craindre : Bloc auriculo ventriculaire BAV

#### 4) Les atteintes rénales du lupus et comment s'expriment-elles ?

- Il s'agit le plus souvent d'une atteinte glomérulaire.
- Se manifeste par un syndrome néphrotique (protéinurie des 24h > 3g/l, hypoalbuminémie < 30, hypoprotidémie < 60g/l) pure ou impure (associé à une hématurie, insuffisance rénale ; HTA)

P2 2025

#### 5) Décrire les caractéristiques cliniques et évolutives de la lésion dermatologique du Lupus cutané aigu

#### 6) Quelle est l'atteinte rénale principale au cours du Lupus ? comment s'exprime-t-elle ?

#### 7) En dehors des médicaments, citer au moins deux mesures importantes à instaurer chez une patiente lupique en âge de procréer ?

- Photoprotection
- Contraception adaptée à évoquer dès la première consultation. Privilégier une contraception progestative, les œstrogènes sont contre-indiqués (pouvant induire des poussées de lupus)
- En cas de désir d'une grossesse, planifier celle-ci ?
- Eviction du tabac

P3 2025

#### 8) Décrire les caractéristiques cliniques et évolutives du lupus cutané chronique.

- Aspect habituel est le lupus discoïde : des plaques limitées associant érythème télangiectasique, squames épaisses annulaires et polycycliques, atrophie cicatricielle
- Touche le visage et les extrémités voire l'ensemble des téguments
- Peut aboutir à une alopécie définitive (atrophie cicatricielle) si elle touche le cuir chevelu
- Résiste au traitement

**9) Décrire l'atteinte articulaire habituellement observée au cours du lupus érythémateux systémique.**

- Oligo-arthrite ou polyarthrite inflammatoire bilatérale et symétrique non destructive et non déformative (déformation possible suite à une hyperlaxité capsulo-ligamentaire « main de jaccoud »)
- Touche les petites et moyennes articulations plus souvent distales : MCP IPP genou cheville carpe
- Épargne le rachis
- Aiguë, rarement subaiguë ou chronique

**10) Quelles séreuses sont habituellement touchées au cours du lupus érythémateux systémique ?**

- Péricarde (Péricardite)
- Plèvre (Pleurésie)

**11) Quels sont les résultats de l'analyse du liquide de l'épanchement dans ce cas (biochimie et cytologie) ?**

- Liquide exsudatif (riche en protéines), à prédominance lymphocytaire

**12) Citez au moins trois atteintes neurologiques observées au cours du lupus érythémateux systémique ?**

- AVC plus souvent ischémique
- Épilepsie
- Myélite

P2 2024

**13) Décrire les lésions du lupus aigu au niveau de la main**

- Lésion érythémateuse, maculeuse, maculo-papuleuse, qui intéresse les zones inter articulaires des doigts
- Épargne les surfaces articulaires
- Disparaît sans laisser de cicatrices

**14) Quelle est l'atteinte cardiaque la plus fréquente au cours du lupus et quel est son pronostic**

- Péricardite
- De bon pronostic, très corticosensible, elle n'évolue pas vers la constriction

**15) Quel anticorps est responsable du lupus néonatal et quelle est la complication qu'on redoute le plus**

**16) Quelle est l'atteinte rénale caractéristique du LED et comment s'exprime-t-elle**

**17) Citer deux anticorps pourvoyeurs d'atteinte nerveuse au cours du lupus mis à part les anti-phospholipides**

- AC anti neurone
- AC anti-ribosome P

# Le syndrome des anticorps anti-phospholipides (SAPL)

P2 2026

**1) Citer au moins trois manifestations cutanées du syndrome des anti-phospholipides**

- Anétodermie
- Livedo racemosa
- Purpura nécrotique des extrémités

**2) Citer trois manifestations biologiques qui évoquent un syndrome des anti-phospholipides en dehors du bilan immunologique ?**

- Thrombopénie modérée
- Anémie hémolytique mécanique
- TCA allongé non corrigé par plasma témoin

**3) Préciser trois manifestations obstétricales du syndrome des anti-phospholipides ?**

- Fausses couches précoces (< 10 SA), spontanées, consécutives, sans cause identifiée
- Mort fœtale in utero (> 10 SA), non expliquée.
- Prématurité inexpliquée

P1 Q11/Q12 2026

**4) Citer au moins cinq situations cliniques qui doivent faire rechercher un syndrome des anti-phospholipides ?**

- AVC chez un sujet jeune
- Thrombose veineuse de siège inhabituel (comme la veine cave supérieure)
- Embolie pulmonaire sans facteur favorisant évident
- Thrombose veineuse spontanée des membres inférieurs ou de siège inhabituel (les thromboses superficielles ne font pas partie des critères diagnostiques)
- Fausses couches précoces (< 10 SA), spontanées, consécutives, sans cause identifiée
- Une mort fœtale in utero (> 10 SA), non expliquée
- Prématurité inexplicée

**5) Citer au moins cinq anomalies biologiques qui évoquent un syndrome des anti-phospholipides**

- Microangiopathie thrombotique : Thrombopénie modérée / Anémie hémolytique mécanique / Schizocytes au frottis
- TCA allongé (Temps de Céphaline Activée non corrigé par le plasma témoin)
- Anticorps anti-cardiolipine
- Anticorps anti-béta2 glycoprotéine 1
- Anticoagulant circulant lupique

P1 2025

**6) Citer 02 manifestations biologiques du SAPL (en dehors de l'immunologie)**

- Allongement de TCA (isolé (taux de prothrombine (TP) normal), non corrigé quand on mélange le plasma du patient avec du plasma de témoin (élimine un déficit en facteur de la coagulation), corrigé par un excès de phospholipides (neutralisation : adsorption des anticorps anti-phospholipides))
- Anémie hémolytique mécanique

**7) Citer 03 manifestations cutanées du SAPL**

- Anétodermie
- Livedo racemosa
- Purpura nécrotique des extrémités
- Nécrose cutanée
- Hémorragies en flammèches sous-unguéales

**NB : il faut citer 03 manifestations seulement**

**8) Citer 03 anomalies de retentissement à l'hémogramme d'une microangiopathie thrombotique**

- Thrombopénie modérée de consommation
- Anémie hémolytique mécanique
- Schizocytes au frottis

P3 2025

**9) Citez au moins quatre situations cliniques devant faire rechercher un syndrome des anti-phospholipides.**

**10) Que doit comprendre le bilan immunologique demandé dans le cadre de la recherche d'un syndrome des anti-phospholipides ?**

- AC anticoagulant circulant de type lupique
- Anticorps anti-cardiolipine
- AC anti- $\beta$ 2-GP-1

P1 2024

**11) Citer au moins 05 situations cliniques qui doivent faire rechercher un syndrome des anti-phospholipides**

**12) Citer au moins 02 situations biologiques qui évoquent un syndrome des anti-phospholipides en dehors du bilan immunologique**

**13) Citer au moins 03 manifestations cutanées du syndrome des anti-phospholipides**

P2 2024

**14) Citer 03 anomalies de retentissement à l'hémogramme de microangiopathie thrombotique**

- Thrombopénie modérée
- Anémie hémolytique mécanique
- Schizocytes au frottis

P3 2024

**15) Citez les 2 principales classes thérapeutiques utilisées au cours du SAPL**

- Antiagrégants plaquettaires
- Anticoagulants : HBPM, AVK

# La maladie de Behçet

P2 2026

**1) Donner cinq caractéristiques de l'aphtose buccale au cours de la maladie de Behçet ?**

- Fréquente
- Récidivante > 3/an
- Multiple voire confluyente, elle peut siéger dans n'importe quelle région de la cavité buccale.
- Douloureuse
- De taille variable
- Favorisée par l'arrêt du tabac
- Associée à des manifestations extra-buccales (non isolées)

**2) Donner trois diagnostics différentiels de l'aphtose buccale de la maladie de Behçet ?**

- Aphtose buccale banale
- Aphtose buccale dans maladies de Crohn
- Aphtose buccale dans maladie cœliaque

**3) Donner les atteintes pronostic engageant le pronostic vital au cours de la maladie de Behçet**

- Atteinte vasculaire
- Atteinte neurologique
- Atteinte digestive

**4) Citer les armes thérapeutiques de la maladie de Behçet ?**

- Anti-inflammatoires : colchicine
- Corticoïdes
- Immunosuppresseurs
- Biothérapie
- Immunomodulateurs

**5) Quelle est l'anomalie biologique attendue au cours d'une thrombose intraventriculaire au cours de la maladie de Behçet ?**

- Syndrome inflammatoire (élévation de la VS, CRP)

**6) Citer trois manifestations de l'ophtalmo-Behçet touchant le pôle postérieur de l'œil ?**

- Vascularite rétinienne
- Œdème maculaire
- Uvéite postérieure

P1 2026

**7) Quelle est l'anomalie biologique attendue au cours de neuro Behçet ?**

- Un syndrome inflammatoire (augmentation de la VS et CRP)

**8) Le syndrome de Hughes-Stoven associe ?**

- Phénomène thrombotique : thrombose de siège inhabituel souvent de la veine cave et phénomène anévrisimal : anévrisme de l'artère pulmonaire

**9) Citer trois manifestations dermatologiques de la maladie de Behçet en dehors de l'aphtose buccale et génitale, ne s'accompagnant pas d'un syndrome inflammatoire**

- Pseudo-folliculite
- Ulcération cutanée
- Papule ou pustule
- Vésicules
- Hyperréactivité cutanée aspécifique aux agressions

**10) Une papillite bilatérale chez un patient connu pour maladie de Behçet impose la recherche de trois manifestations de sa maladie, lesquelles, en précisant les examens complémentaires à compléter**

- Ophtalmo-Behçet: FO, OCT papillaire
- Neuro-Behçet : atteinte parenchymateuse ⇒ IRM cérébrale, PL en l'absence de contre-indication
- Angio-Behçet: TVC ⇒ Angio IRM
- En plus de VS, CRP

**11) Citer cinq caractéristiques de l'atteinte vasculaire de la maladie de Behçet ?**

- Absence de facteurs de risque vasculaire
- Touche les vaisseaux de tous calibres
- Caractère bilatéral
- Caractère récidivant
- Thrombose veineuse de siège inhabituel ou localisation banale
- Bilan inflammatoire positif

**12) Donner les situations cliniques au cours de la maladie de Behçet pouvant s'accompagner d'un bilan inflammatoire positif**

- Angio Behçet
- Neuro Behçet
- Entéro-Behçet
- Atteinte articulaire
- Érythème noueux

P1 2025

**13) 5 caractéristiques de l'atteinte vasculaire de Behçet**

**14) 5 caractéristiques de l'aphtose buccale de Behçet**

- Fréquente
- Récidivante > 3/an
- Multiple voire confluyente, elle peut siéger dans n'importe quelle région de la cavité buccale.
- Douleuruse
- De taille variable
- Favorisée par l'arrêt du tabac
- Associée à des manifestations extra-buccales (non isolées)

P2 2025

**15) Quelles sont les manifestations de la maladie de Behçet qui s'accompagnent de fièvre ?**

- Angio Behçet
- Neuro Behçet
- Entéro-Behçet
- Atteinte articulaire
- Érythème noueux

**16) Quel est le risque d'arrêt de la Colchicine au cours de la maladie de Behçet ?**

- Flambée surtout des manifestations neurologiques et oculaires

P3 2025

**17) Citez au moins quatre manifestations pronostiques de la maladie de Behçet.**

- Oculaire : pronostic fonctionnel
- Vasculaire : vital
- Neurologique : vital et fonctionnel
- Digestive : vital

**18) Quelles sont les caractéristiques de l'aphtose de la maladie de Behçet ?**

P1 2024

**19) Citer 05 caractéristiques de l'aphtose buccale au cours de la maladie de Behçet**

**20) Citer au moins 04 manifestations extra-dermatologiques de la maladie de Behçet**

- Uvéite postérieure
- Thrombose de siège inhabituel (comme la veine cave)
- Arthralgie des articulations porteuses
- Encéphalite

21) Citer les atteintes pouvant engager le pronostic vital au cours de la maladie de Behçet

22) Citer au moins 03 manifestations dermatologiques de la maladie de Behçet en dehors de l'aphtose

P2 2024

23) Quels sont les diagnostics différentiels de l'aphtose buccale de la maladie de Behçet ?

- Aphtose buccale banale récurrente
- Maladie de Crohn
- RCUH
- Maladie coéliquae
- Hémopathies
- Carence en fer et vitamines B9 et B12
- Infections mycosiques ou virales
- Chimiothérapie ; médicaments

24) Dans quelles situations le bilan inflammatoire est positif au cours de la maladie de Behçet

P3 2024

25) Décrivez le test d'hypersensibilité au cours de la maladie de Behçet

- **Test pathergique :**
  - Il consiste en une **injection intradermique** de sérum physiologique (placebo).
  - Le site d'injection est ensuite observé après **24 à 48 heures**.
  - Un **test positif** correspond à l'apparition d'une **papule**, d'une **pseudo-pustule** ou d'une **vésicule** au site de la piqûre, traduisant une hyperréactivité cutanée.

# La sclérodermie systémique

P2 2026

**1) Citer trois anomalies retrouvées à la capillaroscopie au cours de la sclérodermie ?**

- Présence de mégalo-capillaires
- Raréfaction des capillaires
- Hémorragie sous-unguéales (spontanées)

**2) Quand demander une échodoppler cardiaque chez un patient suivi pour sclérodermie systémique, en précisant pourquoi ?**

- Echo-Doppler cardiaque annuelle, pour dépister une hypertension artérielle pulmonaire asymptomatique
- Si le patient présente des symptômes au cours des consultations on le fait immédiatement

P1 2026

**3) Quelles sont les complications à craindre du reflux gastro-œsophagien au cours de la sclérodermie systémique**

- Œsophagite peptique
- Endobrachyœsophage
- Adénocarcinome de l'œsophage

**4) Au cours de la sclérodermie, l'hypertension artérielle pulmonaire asymptomatique est à dépister par quel examen para clinique, et à quel rythme ?**

- Dépister par échodoppler cardiaque annuelle

**5) Citer les lésions scanographiques retrouvées en cas de pneumopathies interstitielles liées à la sclérodermie**

- A la radiographie standard : soit image normale ou opacités réticulées
- A la TDM : →Image en verre dépoli en cas d'inflammation  
→Image en rayon de miel en cas de fibrose

P1 2025

**6) 3 anomalies capillaroscopiques de sclérodermie**

- Présence de mégacapillaire
- Raréfaction des capillaires
- Hémorragie sous unguéale (spontanées)

P3 2025

**7) Citer les anomalies biologiques observées au cours de la crise rénale sclérodermique.**

- Anémie hémolytique mécanique : Schizocytes au frottis sanguin
- Créatinémie rapidement élevée

**8) Quelles sont les anomalies retrouvées à la capillaroscopie au cours de la sclérodermie ?**

**9) Quels sont les éléments orientant vers le caractère secondaire d'un phénomène de Raynaud**

- Perte du caractère saisonnier
- Touche tous les doigts y compris le pouce.
- Existence de manifestations systémiques
- Absence de facteur déclenchant
- Présence de troubles trophiques

- La majorité des phénomènes de Raynaud sont primaires (*synonymes : phénomène de Raynaud primitif ou essentiel ; maladie de Raynaud*). Il s'agit du trouble vasomoteur le plus fréquent dont la prévalence est très élevée dans la population générale (5 à 15 %). Une enquête étiologique est cependant nécessaire pour éliminer un phénomène de Raynaud secondaire à une maladie auto-immune systémique, en particulier la sclérodémie systémique.
- Le phénomène de Raynaud secondaire est globalement plus sévère, sans recrudescence hivernale nette, les crises sont plus fréquentes et plus longues et les troubles trophiques sont possibles. Le **Tableau 1** illustre les éléments en faveur d'un phénomène de Raynaud primaire ou secondaire.

**Tableau 1 : ÉLÉMENTS CLINIQUES EN FAVEUR D'UN PHÉNOMÈNE DE RAYNAUD PRIMAIRE OU SECONDAIRE**

| Critères                                                                        | Phénomène de Raynaud primaire = Maladie de Raynaud              | Phénomène de Raynaud secondaire                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Antécédent familial</b>                                                      | Fréquent                                                        | Rare                                                                                                                                                      |
| <b>Âge de début</b>                                                             | Avant l'âge de 35-40 ans (le plus souvent à l'adolescence)      | A tout âge, souvent après 40 ans                                                                                                                          |
| <b>Ratio femme/homme</b>                                                        | Touche préférentiellement la femme                              | Survenue possible aussi chez un homme                                                                                                                     |
| <b>Facteur déclenchant</b>                                                      | Le froid, les variations de température, le stress              | Pas de facteur déclenchant net                                                                                                                            |
| <b>Distribution des symptômes</b>                                               | Bilatérale et symétrique                                        | Unilatérale ou asymétrique                                                                                                                                |
| <b>Clinique</b>                                                                 | Epargne les pouces                                              | Atteinte des pouces                                                                                                                                       |
| <b>Examen physique</b>                                                          | Normal hors crise                                               | Anomalies possibles : perte d'un pouls radial ou ulnaire, signes associés de maladies auto-immunes systémiques.                                           |
| <b>Troubles trophiques de doigts</b>                                            | Absence                                                         | Présence (actuels ou passés) : ulcération(s) ( <b>ulcère cutané</b> ), cicatrice(s) rétractile(s) pulpaire(s), doigts scléreux.                           |
| <b>Facteur professionnel</b>                                                    | Absent                                                          | Possible                                                                                                                                                  |
| <b>Autres signes associés en lien avec une maladie systémique</b>               | Absence de signe clinique orientant vers une maladie systémique | Signes de sclérodémie systémique, ou autres maladies autoimmunes systémiques : dermatomyosite, lupus systémique, connectivite mixte, syndrome de Sjögren. |
| <b>Autres signes associés en faveur d'une sténose ou obstruction artérielle</b> | Absence de signe d'artériopathie des membres supérieurs         | Perte d'un pouls aux membres supérieurs, asymétrie tensionnelle, présence d'un souffle vasculaire.                                                        |
| <b>Pronostic</b>                                                                | Excellent                                                       | Fonction de la cause                                                                                                                                      |

P2 2025

10) Citer les manifestations clinico-biologiques de la crise rénale sclérodermique.

- Clinique : HTA sévère, Oligo-anurie (insuffisance rénale)

- Biologie : anémie hémolytique mécanique ; créatinémie élevée ; DFG bas

**11) Citer les trois manifestations digestives les plus fréquentes de la sclérodermie.**

- Reflux gastro-œsophagien
- Pyrosis
- Gastroparésie

**P1 2024 :**

**12) Citer les manifestations cliniques du CREST syndrome**

- Calcinose, Phénomène de Raynaud, dysfonctionnement œsophagien, télangiectasie, sclérodactylie

**13) Citer 03 anomalies retrouvées à la capillaroscopie au cours de la sclérodermie**

**14) Pourquoi la corticothérapie à forte dose est à éviter au cours de la sclérodermie**

- Parce qu'elle peut favoriser ou déclencher une crise rénale sclérodermique mettant le pronostic vital en jeu

**P2 2024**

**15) Quelles sont les deux principales étiologies de la dyspnée au cours de la sclérodermie**

- Pneumopathie interstitielle diffuse
- Hypertension artérielle pulmonaire

**16) Comment se manifeste cliniquement et biologiquement la crise rénale sclérodermique ?**

P3 2024

**17) Citez 2 signes pouvant être observés à la capillaroscopie au cours de la sclérodermie**

**18) Donnez 2 manifestations cliniques et /ou biologiques liées à une atteinte de l'intestin grêle au cours de la sclérodermie**

- Diarrhée
- Syndrome pseudo-occlusif

**19) Citez deux facteurs exogènes incriminés dans la physiopathologie de la sclérodermie**

- Solvants organiques
- Silice

**20) Citez 3 anticorps retrouvés dans la sclérodermie**

- FAN
- Ac anti scl 70
- AC anti centromère
- AC anti-polymérase 3

# Les Granulomatoses systémiques (Sarcoïdose)

P2 2025

**1) Décrire les adénopathies médiastinales au cours de la Sarcoïdose.**

- Adénopathie hilare
- Symétrique bilatérale
- Polycycliques
- Non compressive
- Volumineuses

P1 2024

**2) Citer au moins 04 étiologies des granulomatoses systémiques**

- Tuberculose
- Sarcoïdose
- Maladie de Horton
- Granulomateuse avec polyangéite (vascularite à ANCA)

**3) Citer au moins 04 manifestations cliniques pouvant évoquer une granulomatose**

- Dyspnée chronique
- Uvéite antérieure avec précipitation rétro-cornéenne granulomateuse
- Atteinte hépatique (cytolyse)
- Splénomégalie

P2 2024

**4) Citez au moins 04 manifestation cardiaque des granulomateuses systémiques ?**

- Troubles de rythme
- Troubles de conduction
- Myocardite
- Atteinte coronaire (trouble ischémique)

**5) Décrire les adénopathies de la sarcoïdose pulmonaire**

P3 2024

**6) Le syndrome de HEERFORDT associe**

- Uvéite antérieure
- Parotidomégalie
- Paralysie faciale périphérique
- Fièvre

**7) Caractérisez la lésion histologique de la sarcoïdose**

- Granulome épithélio-giganto-cellulaire sans nécrose caséuse plus souvent

# Le Syndrome de Gougerot-Sjögren

P2i 2026

- 1) Quelles sont les paires crâniennes les plus touchées au cours du syndrome de Gougerot-Sjögren

- Le nerf Trijumeau
- Le nerf Facial
- Le nerf vestibulocochléaire

- 2) Quelles sont les complications à évoquer devant un pic monoclonal des gammaglobulines chez un patient suivi pour un syndrome de Gougerot-Sjögren ?

- Dégénérescence lymphomateuse B

- 3) Quel diagnostic est évoqué devant l'apparition d'un syndrome de glomérulonéphrite chez un patient suivi pour un syndrome de Gougerot Sjogren ?

- Vascularite cryoglobulinémique

P1 2026

- 4) Citez deux diagnostics à évoquer devant un purpura vasculaire au cours du syndrome de Gougerot-Sjögren

- Hyper-gammaglobulinémie
- Vascularite cryoglobulinémique

**5) Citez trois étiologies autres qu'un syndrome de Gougerot-Sjögren, D'une parotidomégalie bilatérale ?**

- Sarcoïdose
- Maladie à IgG4
- Cirrhose éthylique
- Lymphome
- Diabète

P1 2015

**6) 4 marqueurs immunologiques de Gougerot**

- Anticorps antinucléaire (FAN)
- Anticorps anti SSa (Ro 52, Ro 60 plus spécifique)
- Anticorps anti SSb La
- Facteur rhumatoïde

**7) Anomalie électrique habituelle du syndrome de Gougerot**

- Bloc auriculo-ventriculaire « BAV » congénital

P3 2025

**8) Citez les deux diagnostics à évoquer devant un purpura vasculaire au cours du syndrome de Gougerot-Sjögren ?**

P1 2024 :

**9) Citer au moins 03 manifestations graves de syndrome de Gougerot-Sjögren**

- Manifestation pulmonaire : pneumopathies interstitielles diffuses
- Manifestation neurologique : atteinte centrale plus grave : vascularite de système nerveux central
- Manifestation rénale : néphropathies tubulo-interstitielles

**10) Citer au moins 04 anomalies biologiques observées au cours du syndrome de Gougerot-Sjögren**

- Lymphopénie
- Anémie auto-immune
- Thrombopénie auto-immune
- Hypergammaglobulinémie polyclonale

P2 2024

**11) Citez au moins 02 anomalies biologiques faisant suspecter une dégénérescence lymphomateuse au cours de syndrome de Gougerot ?**

- Hypergammaglobulinémie monoclonale
- Cryoglobulinémie 1

**12) Citez deux atteintes nerveuses les plus fréquentes au cours du syndrome de Gougerot**

- Atteinte des paires crâniennes : plus souvent trijumeau
- Mononeuropathie multiple

P3 2024

**13) Donnez 3 manifestations cliniques évocatrices d'une dégénérescence lymphomatose au cours du syndrome de Gougerot-Sjögren**

- Hypertrophie parotidienne persistante
- Fièvre et altération de l'état générale
- Syndrome tumoral

**14) Citez 2 manifestations biologiques évocatrices d'une dégénérescence lymphomatose au cours du syndrome de Gougerot Sjögren**

**15) Citez les 2 atteintes neurologiques les plus fréquentes lors du syndrome de Gougerot-Sjögren**

**16) Citez 3 étiologies en dehors du syndrome de Gougerot-Sjögren de parotidomégalie bilatérale**

# Les maladies auto-inflammatoires (Maladie de Still)

P1 2026

**1) Décrire la manifestation dermatologique la plus caractéristique de la maladie de Still ?**

- Rash rose saumon, souvent discret
- Evanescence : disparaît après les pics
- Maculo-papuleux non prurigineux
- Prédomine au niveau de tronc et racines des membres
- Peut-être induit par le grattage et la pression
- Apparaît pendant les pics fébriles
- Peut-être induit par la pression, grattage (phénomène de Koebner-Like)

**2) Quelle est la complication redoutable rattachée systématiquement au cours de la maladie de Still ?**

- Syndrome d'activation macrophagique (SAM)

P2 2025

**3) Citer au moins trois diagnostics différentiels du rash cutané retrouvé dans la maladie de Still.**

- Mononucléose infectieuse
- Toxidermie médicamenteuse
- Syphilis secondaire
- Pityriasis rosé de Gilbert

**4) Citer quatre manifestations biologiques du Syndrome d'activation macrophagique.**

- Cytopénie (anémie, thrombopénie, leucopénie)
- Hyperferritinémie
- Fibrinogène bas
- TG ↑↑

P1 2024

**5) Décrire la manifestation dermatologique la plus caractéristique de la maladie de still**

P1 2024

**6) Citer au moins 03 diagnostics différentiels de la maladie de Still**

- Endocardite
- Candidose systémique
- Leucémie

**7) 04 étiologies d'hyper ferritinémie**

- Maladie auto inflammatoire ex : maladie de still
- Syndrome d'activation macrophagique
- Hépatites
- Lymphomes
- Hémochromatose
- Rhumatisme inflammatoire

**8) Dosage de ferritine glycosylée**

- **La formulation exacte de la question est absente, mais** la ferritine glycosylée trouve son intérêt au cours de la maladie de Still : lorsqu'elle est  $< 20 \%$ , elle est très évocatrice de cette dernière

P2 2024

9) Quels sont les diagnostics différentiels du rash cutané retrouvé dans la maladie de Still

10) Quelle est la caractéristique commune des maladies inflammatoires systémiques ?

- La fièvre

P3 2024

11) Donnez 2 complications majeures pouvant engager le pronostic vital lors de la maladie de still

- Syndrome d'activation macrophagique
- Atteinte cardiaque

12) Citez au moins 2 anomalies biologiques et au moins une anomalie clinique du syndrome d'activation macrophagique

- 

**Clinique :**

- Fièvre, splénomégalie, hépatomégalie, adénopathies

**Biologiques :**

- Inflammation au plafond : VS, CRP, Ferritine, TG augmentés (blocage de la lipoprotéine lipase)
- LDH augmenté
- Fibrinogène bas
- Cytolyse hépatique
- Pancytopénie, CIVD

# Les Myopathies inflammatoires

P2 2026

**1) Citer 3 origines possibles de l'atteinte pulmonaire parenchymateuse au cours des myosites ?**

- Origine médicamenteuse (méthotrexate)
- Origine inflammatoire (par le biais de la maladie)
- Pneumopathie d'inhalation (fausse route par déficit des muscles laryngo-pharyngés)

**2) Citer cinq manifestations dermatologiques de la dermatomyosite ?**

- Erythème en « V » (signe de décolleté / châte)
- Papules de Gottron (érythème ou macule violacée en face d'extension)
- Signe de manucure : érythème péri unguéal
- Erythème périorbitaire en lunette
- Erythro- œdème lilacé des paupières

**3) Quels sont les signes de gravité d'une myopathie inflammatoire ?**

- Dysphagie (atteinte pharyngolaryngée)
- Dyspnée (atteinte pulmonaire)
- Atteinte cardiaque
- Perte d'autonomie

P1 2026

**4) Citez au moins 04 caractéristiques de l'atteinte articulaire au cours des myopathies inflammatoires ?**

- Polyarthralgies inflammatoires
- Bilatérale et symétrique
- Périphérique prédominant sur les petites et moyennes articulations
- Non déformantes ni destructrices .

**5) On doit rechercher systématiquement au cours de la dermatomyosite notamment chez le sujet âgé ?**

- Un syndrome paranéoplasique.

**6) Citez au moins 4 des caractéristiques classiques de l'atteinte musculaire au cours des myosites ?**

- Déficit musculaire progressif
- Bilatéral Symétrique
- Prédominance proximale (ceintures scapulaire et pelvienne)
- Myalgies spontanées ou provoquées

**7) Citez 03 origines possibles de l'atteinte pulmonaire parenchymateuse au cours des myosites ?**

- Origine médicamenteuse (méthotrexate)
- Origine inflammatoire (par le biais de la maladie)
- Pneumopathie d'inhalation (fausse route par déficit des muscles laryngo-pharyngés)

**8) Citer cinq manifestations dermatologiques de la dermatomyosite ?**

**9) Quels sont les signes de gravité d'une myopathie inflammatoire ?**

P1 2025

**10) 4 caractéristiques de l'atteinte musculaire de la myopathie inflammatoire**

**11) 3 manifestations dermatologique évocatrices de dermatomyosite**

P3 2025

**12) Citez au moins cinq atteintes cutanées observées au cours de la dermatomyosite.**

**13) Quelles sont les atteintes pronostiques au cours des myopathies inflammatoires ?**

P2 2025

**14) Quels traitements sont utilisés au cours des formes sévères des myopathies inflammatoires ?**

- Corticothérapie à forte dose (Bolus)
- Immunosuppresseurs (cyclophosphamide)
- Biothérapie (rituximab)
- Immunoglobuline

**15) Citer au moins trois origines de l'atteinte respiratoire au cours des myopathies inflammatoires.**

**16) Citer au moins trois signes de gravité d'une myopathie inflammatoire.**

**17) Au cours de la dermatomyosite chez le sujet âgé, quelle pathologie à rechercher ?**

**18) Citer quatre myopathies d'origine inflammatoire.**

- Polymyosite
- Dermatomyosite
- Myosite nécrosante auto-immune
- Myopathie à inclusion

P1 2024

**19) Quels sont les manifestations dermatologiques les plus évocatrices de la dermatomyosite**

**20) Citer les signes de gravité d'une myopathie inflammatoire**

P2 2024 :

**21) Quelles sont les caractéristiques en commun des différentes myopathies inflammatoires ?**

# Les Amyloses

P2 2026

1) Citer deux maladies de surcharge dont les signes d'appel peuvent être cardiaque

- Amylose TTR « sénile »
- Amylose héréditaires « TTR mutée »

2) Citer les caractéristiques (clinique, biologique, évolutives) de l'amylose rénale ?

Néphropathie glomérulaire

- **Clinique** : syndrome néphrotique pur, œdème des membres inférieurs, HTA souvent absente
- **Biologie** : protéinurie généralement massive, hypoalbuminémie, exceptionnellement hématurie microscopique
- **Evolution** : vers insuffisance rénale chronique

P1 2026

3) Citez les 03 sites de biopsies recommandés en cas de suspicion d'amylose ?

- Glandes salivaires accessoires
- Muqueuse rectale
- La graisse abdominale péri ombilicale

4) Quelle est l'atteinte neurologique au cours de l'amylose ?

- Atteinte neurologique périphérique : polyneuropathie sensitive puis sensitivo-motrice ; on peut avoir également neuropathie autonome

P1 2025

#### **5) 4 présentations de l'amylose cardiaque**

- Amylose AA (substance amyloïde A)
- Amylose AL (chaines légères)
- Amylose ATTR (transthyrétine sénile)
- Amylose héréditaire (transthyrétine mutée)

P1 2024

#### **6) Quelles sont les amyloses associées à une plus grande fréquence de l'atteinte rénale**

- Amylose AL
- Amylose AA

#### **7) Quel est le type d'atteinte rénale observé au cours de l'amylose AL**

- Néphropathie glomérulaire

#### **8) Citer un signe cutané caractéristique de L'amylose**

- Purpura périorbitaire ecchymotique violacé en lunettes

P3 2024 :

**9) Quelles sont les amyloses associées à une grande fréquence de l'atteinte rénale**

- Amylose AA
- Amylose AL

**10) Citez une caractéristique clinique et une évolutive de l'atteinte rénale au cours de l'amylose**

- Néphropathie glomérulaire se manifeste par syndrome néphrotique pure qui évolue au long vers une insuffisance rénale chronique jusqu'à stade de dialyse

# Les vascularites systémiques

P2 2026

**1) Citer cinq manifestations cliniques évocatrices de maladie de Horton ?**

- Céphalées temporales
- Claudication de la mâchoire
- Hyperesthésie du cuir chevelu
- Troubles visuels (diplopie, vision floue ...)
- Douleurs articulaires prédominant aux ceintures

**2) Une femme jeune qui présente une anisotension, des polyarthralgies inflammatoires doit faire évoquer quelle vascularite ?**

- L'artérite de Takayashu

**3) Quel diagnostic est à évoquer en cas d'association d'uvéite, nodules pulmonaires et ANCA positifs ?**

- Granulomateuse avec polyangéite GPA (maladie de Wegener)

**4) Citez les deux complications caractéristiques les plus redoutables au cours des vascularites à ANCA ?**

- Atteinte pulmonaire : hémorragie alvéolaire
- Atteinte rénale : glomérulonéphrite rapidement progressive

P1 2026

**5) Quelle est la première complication à redouter en cas d'artérite à cellules géantes ?**

- La cécité définitive

**6) Quels sont les buts et principaux traitements des vascularites à ANCA ?**

- Obtenir une rémission
- Prévenir les récurrences

**7) Citez les deux complications caractéristiques les plus redoutables au cours des vascularites à ANCA ?**

- Atteinte pulmonaire : hémorragie alvéolaire
- Atteinte rénale : glomérulonéphrite rapidement progressive

**8) Citer les vascularites de petit calibre liées aux ANCA.**

- Maladie de Wegener : granulomateuse avec poly angéite
- Maladie Churg et Strauss : granulomateuse éosinophilique avec poly angéite
- Polyangéite microscopique

P1 2025

**9) 2 complications redoutables des vascularites à ANCA**

**10) 4 manifestations cliniques de la maladie d'Horton**

- Céphalées temporales
- Unilatérales ou bilatérales
- Claudication de la mâchoire
- Hyperesthésie du cuir chevelu
- Troubles visuels (diplopie, vision floue ...)
- Douleurs articulaires prédominant aux ceintures
- Altération de l'état général, fièvre

P3 2025

**11) Quelles sont les vascularites à ANCA ?**

**12) Citez les deux atteintes pronostiques les plus redoutables des vascularites à ANCA ?**

**13) Citez au moins cinq manifestations cliniques de l'artérite à cellules géantes ?**

P2 2025

**14) Citer trois lésions évoquant une vascularite.**

- Livedo racemosa
- Purpura vasculaire (pétéchial, déclive infiltré)
- Nécrose cutanée

P1 2024 :

**15) Citer les vascularites de petit calibre liées aux ANCA**

**16) Citer les 02 complications caractéristiques les plus redoutables au cours des vascularites à ANCA**

**17) Citer au moins 04 manifestation cliniques évocatrices d'une artérite à cellules géantes**

**18) Citez au moins 03 signes cliniques cutanés des vascularites**

# Approche diagnostique des maladies rares

P2 2026

- 1) Un homme jeune qui présente un syndrome parkinsonien associé à une anémie hémolytique à test de Coombs négatif fait évoquer quelle maladie ?

- Maladie de Wilson

- 2) La maladie de Fabry correspond à quel déficit ?

- Déficit en Alpha galactosidase A

- 3) L'association d'acroparesthésies et d'hypoacousie chez un jeune homme doit faire évoquer ?

- Maladie de Fabry

- 4) Un ATCD de chirurgie pour carcinome médullaire de la thyroïde dans la famille chez un patient qui présente une hypercalcémie doit faire évoquer ?

- Néoplasie endocrinienne multiple 02 (NEM 2)

- 5) Un ATCD de chirurgie pour adénome hypophysaire dans la famille chez un patient qui présente une hypercalcémie doit faire évoquer ?

- Néoplasie endocrinienne multiple 01 (NEM 1)

P1 2026

**6) Citez deux manifestations révélatrices de l'hyperhomocystéinémie constitutionnelle ?**

- Thrombose récurrentes
- Manifestation neurologique (ex : tremblement)

P1 2025

**7) 3 maladies de surcharge pouvant être révélées par des cardiomyopathies**

- Maladie de Fabry
- Maladie de pompe
- Hémochromatose

**8) 3 manifestations osseuses de Gaucher**

- Ostéoporose, ostéopénie
- Douleurs osseuses chroniques : Crise osseuse
- Ostéonécrose aseptique
- Déformation en flacon d'Erlenmeyer

P1 2024

**9) L'association d'une anémie hémolytique et hépatopathie chronique chez un sujet jeune doit faire évoquer**

- Maladie de Wilson

P1 2024

**10) Citez au moins 02 maladies de surcharge ayant une atteinte cardiaque**

P3 2024

**11) Quelle est la sphingolipidose la plus fréquente ? qu'elle est sa cause ?**

- Maladie de Gaucher
- La cause : une mutation génétique du gène GBA1  $\Rightarrow$  déficit en  $\beta$  glucocérébrosidase

# Les déficits immunitaires

P3 2025

**1) Citez au moins quatre causes de déficit immunitaire acquis**

- Diabète
- VIH
- Dénutrition
- Grossesse

P2 2025

**2) Citer au moins quatre causes de déficit immunitaire secondaire.**

**3) Quelle anomalie du complément peut être à l'origine de l'angio-œdème bradykinique**

- Déficit en inhibiteur C1q

P1 2024

**4) Citer 03 manifestations pouvant révéler un déficit immunitaire primitif**

- Infection à répétition
- Manifestation auto-immune
- Syndrome lymphoprolifératif

**5) Citer au moins 03 causes de déficit immunitaire secondaire**

**6) Quel déficit en complément peut être à l'origine d'angio-œdème bradykinique**

P2 2024

**7) Citez les différentes étiologies des déficits immunitaires secondaires**

**8) Citez deux manifestations auto-immunes pouvant s'associer au déficit en IGA**

- Lupus
- Maladie cœliaque

# Principes du traitement et du suivi des maladies systémiques

P2 2026

**1) Citer un immunosuppresseur pouvant être utilisé au cours de la grossesse ?**

- Azathioprine (imurel)

P1 2026

**2) Quel est l'effet indésirable que l'on redoute lors de la prescription de l'hydroxychloroquine au long cours**

- La toxicité rétinienne

**3) Comment éliminer l'effet irritant le plus marqué de la prescription de l'hydroxychloroquine au long ?**

- Un examen ophtalmologique systématique annuel : FO + OCT maculaire, champ visuel, électrorétinogramme (2/3 examens sont obligatoires)

P3 2025

**4) Quel est l'effet secondaire principal à rechercher chez un patient sous hydroxychloroquine ?**

P2 2025

**5) Citer quatre effets secondaires liés au cyclophosphamide.**

- Effet tératogène
- Alopécie
- Toxicité médullaire (cytopénie)

- Azoospermie et insuffisance ovarienne (stérilité)

**6) Citer les deux classes thérapeutiques utilisées au cours du traitement du phénomène de Raynaud.**

- Inhibiteurs calciques
- Antagonistes des récepteurs de l'endothéline
- Analogue de la prostaglandine
- Inhibiteurs de la PDE5 (sildénafil)

**7) Citer au moins cinq effets secondaires d'une corticothérapie au long cours**

- HTA
- Diabète cortico-induit
- Ostéoporose
- Myopathies cortisoniques
- Infections
- Glaucome, cataracte

P1 2024

**8) Quel effet secondaire sur l'appareil urinaire est à craindre lors de l'utilisation de cyclophosphamide ?**

- Cancer de la vessie

P2 2024

**9) Quel est l'effet secondaire de l'hydroxychloroquine qu'on redoute le plus ?**

P3 2024

**10) Citez 2 précautions à prendre lors de l'administration de l'endoxane pour diminuer le risque de la cystite hémorragique**

- Bonne hydratation
- Administration d'un protecteur de vessie « Mesna/ Uromitexan »

## *L'atteinte articulaire (résumé)*

| LUPUS                                                                                                                                                | GOUGEROT                                                  | MYOPATHIE                             | AMYLOSE                                                                                            | BEHCET                                                  | Still                                                     | SACROIDOSE                        | SCLERODERMI<br>E                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Polyarthrite<br>(peut avoir oligo-arthrite)                                                                                                          | Polyarthralgie                                            | Polyarthralgies                       | Polyarthralgie                                                                                     | arthralgie<br>Oligo-arthralgie<br>fixes                 | Arthralgie<br>Srthrite                                    | Arthralgies                       | Arthralgie rarement<br>arthrite sauf si sd de<br>chevauchement        |
| <b>NON DEFORMANTE NON DESTRUCTRISE</b>                                                                                                               |                                                           |                                       |                                                                                                    |                                                         |                                                           |                                   |                                                                       |
| <b>INFLAMMATOIRE</b> apparaît 2eme moite la nuit , dérouillage matinale sup a 1H                                                                     |                                                           |                                       |                                                                                                    |                                                         |                                                           |                                   |                                                                       |
| Bilatérale<br>symétrique                                                                                                                             |                                                           | Bilatérale<br>et<br>symétrique        | Bilatérale<br>et<br>symétrique                                                                     | Asymétrique ??<br>Recidivante                           | Symétrique ou<br>aquométrique                             | Bilatérale<br>symétrique          | Bilatérale et symétrique                                              |
| On peut voir des<br>arthrite sub aigu<br>rarement , plus<br>rarement<br>chronique<br>( recherche<br>association a la<br>polyarthrite<br>rhumatoïde ) |                                                           | Perepherique +++                      |                                                                                                    | Si ponction<br>liquide<br>inflammatoire<br>riche en PNN |                                                           |                                   | Rarement arthrite<br>( rechercher sd de<br>chovechement )             |
| Touche les petit<br>et moyen<br>articulation plus<br>souvent distale :<br>MCP IPP genou<br>carpe cheville<br>Épargne le rachis                       | Touche grosses<br>et moyennes<br>petites<br>articulations | Petites<br>et moyenne<br>articulation | Touche les<br>grosses moyenne<br>et petites<br>articulations                                       | Articulations<br>porteurs genou<br>cheville             | Tous les<br>articulations<br>MCP MTP<br>genoux chevilles  | Gennou cheville<br>Coudes poignet | Prédomine sur les<br>petit articulations<br>poignets chevilles<br>ipp |
| Associe au mains<br>de jaccoud :<br>déformation<br>Arthromyalgie ;<br>tenosynovite                                                                   |                                                           |                                       | Syndrome de canal<br>carpien fréquent :<br>atteinte des tendant<br>responsable des<br>déformations | Précoce peut<br>précéder plusieurs<br>années            | Peut être<br>Destructrice dans<br>les formes<br>chronique |                                   | Déformation lie a la<br>rétraction liée a la<br>sclérose cutanée      |

# Partie pratique

## Cas cliniques

Rappel :

**« Ce corrigé type est  
proposé à titre indicatif ;  
certaines réponses  
peuvent être incomplètes  
ou comporter des erreurs,  
sans intention de nuire ou  
d'induire en erreur »**

## Cas clinique N°01 (P2 2026)

Mr M.R âgé de 24 ans aux antécédents d'hospitalisation pour fièvre au long cours à l'âge de 13 ans. Est reçu aux urgences pour douleurs thoraciques rétrosternales soulagées par la position penchée en avant, évoluant depuis 03 jours. Il rapporte une fièvre à 39-40°C vespérale avec apyrexie matinale, apparue 15 jours auparavant. Il s'y associe des douleurs pharyngées, des gonalgies inflammatoires, des myalgies et une toux sèche. Il vous signale la notion de dyspnée d'effort stade 02 d'installation récente sans hémoptysie

L'Examen clinique retrouve une pression artérielle est à **135/80 mm Hg**, FC : **120/min**, FR : **22 cycles /min**, T° : **39.4°C** des lésions cutanées érythémateuses qui selon le patient disparaissent une fois que la fièvre régresse. La gorge est érythémateuse, l'auscultation pulmonaire est normale, les articulations sont libres. On ne retrouve pas de souffle cardiaque ni adénopathie périphérique ni de signe de Homans. On note une splénomégalie type 01 sans hépatomégalie ni circulation veineuse collatérale. La chimie des urines est sans anomalies.

Le bilan retrouve : GB :**23000 /mm<sup>3</sup>**, PNN : **9000/mm<sup>3</sup>**, Lymphocytes :**1200 /mm<sup>3</sup>**, HB : **11g/dL**, VGM : **75 fL**, CCMH : **30 g/dL** Plaquettes : **350000 /mm<sup>3</sup>**, CRP : **150 mg/L**, VS :**120 mm**, fibrinogène : **6 g/L**

Les bilans rénal et hépatique sont corrects de même que les enzymes musculaires (CPK ; LDH) Les troponines et protéinurie des 24h sont normales. L'haptoglobine est normale, Le coefficient de saturation est à 22%, la ferritinémie est à 10 fois la normale. Taux de cholestérol et de TG sont normaux Les sérologies virales B, C, CMV, HIV, Felix et Widal et de la Leishmaniose sont négatives. Les fractions du complément C3, C4 ne sont pas consommés

Les FAN, les ANCA et les anti-CCP sont normaux

Hémocultures négatives

ECG : micro-voltage, pas d'aspect S1Q3, pas d'anomalie de repolarisation

TLT : rectitude de bord gauche du cœur

**Echo-Doppler cardiaque** : épanchement cardiaque, absence de végétations, PAPS normale, cinétique cardiaque normale

**TDM thoraco-abdomino-pelvienne** : splénomégalie à 19 cm

### Questions

**1) Devant les douleurs thoraciques, vous retenez un diagnostic lequel, justifiez votre réponse**

- **Péricardite**

**Justification**

- Douleurs thoraciques rétrosternales, soulagée par la position penchée en avant, dyspnée d'effort stade 02 sans hémoptysie
- Examen clinique retrouve : tachycardie à 120 batt/min, polypnée à 22cycles, auscultation pulmonaire normale avec absence d'atteinte pulmonaire à TLT et TDM thoracique éliminant une origine pulmonaire, pas de souffle cardiaque
- Micro-voltage à ECG, absence d'anomalie de repolarisation (pas de SCA)
- TLT : rectitude du bord gauche du cœur
- Epanchement cardiaque à l'échodoppler cardiaque sans végétations et hémoculture négative (pas d'endocardite)

**2) Caractérisez l'anémie**

- Anémie microcytaire hypochrome probablement inflammatoire
- Anémie : hémoglobine inférieure à 14 (11)
- Microcytaire : VGM inférieur à 80 (75)
- Hypochrome CCMH inférieure à 32 (30)
- Taux d'haptoglobine est normale, coefficient de saturation normale à 22%
- Fibrinogène élevé à 6g/L (supérieur à 4)

### 3) Quel diagnostic retenez-vous. Justifiez votre réponse

- Maladie de Still

#### **Justification :**

- Signes en faveur : fièvre au long cours prédominant le soir avec apyrexie matinale, odynophagie avec examen clinique normal, syndrome arthro-myalgies (myalgie et gonalgies inflammatoires), rash cutané évanescent (survient quelques heures puis disparaît), splénomégalie, atteinte cardiaque (péricardite la plus fréquente dans maladie de still)
- Biologie : bilan inflammatoire positif (hyperleucocytose neutrophile, VS et CRP augmentée, fibrinogène élevé)
- Diagnostic d'exclusion : élimination

***Infections virales*** (sérologies Hiv, CMV, HBV négative), ***infections bactériennes*** (leishmaniose négative, hémocultures négatives)

***Néoplasie*** : pas de masse objectivée à la TDM

***Maladie auto-immune*** : bilan immunologique négatif FAN ANCA anti-CCP sont normaux, fractions du complément non consommées

#### **4) Donnez les Caractéristiques de l'atteinte dermatologique**

- Rash rose saumon, souvent discret
- Evanescent : disparaît après les pics
- Maculo-papuleux non prurigineux
- Prédomine au niveau du tronc et racines des membres
- Peut être induit par le grattage et la pression
- Apparaît pendant les pics fébriles
- Peut-être induit par la pression, grattage (phénomène de Koebner-Like)

#### **5) Quel paramètre biologique demandez-vous pour renforcer votre diagnostic ? et quelle valeur allez-vous retrouver ?**

- Ferritine glycosylée, retrouvée basse, inférieure à 20%

#### **6) Le patient présente une complication, laquelle ?**

- Atteinte cardiaque : péricardite

#### **7) Devant cette maladie, il existe une complication redoutable que le patient ne présente pas, laquelle ?**

- Syndrome d'activation macrophagique (SAM)

**8) Quels sont les éléments de l'observation qui vous permettent d'écarter cette complication ?**

- Les éléments qui permettent d'écarter SAM sont :

**Clinique :**

- Absence d'hépatomégalie et adénopathies

**Biologique :**

- Taux de triglycérides et LDH normaux
- Pas de cytolysé hépatique
- Absence de cytopénie : présence d'une anémie, hyperleucocytose neutrophile (supérieur à 10000 et PNN supérieur à 7000)
- Fibrinogène élevé (supérieur à 4) et non abaissé

**9) Quels sont les modes d'évolution de cette maladie ? Quel mode présente le patient**

- 1/3 mono-poussée : un épisode dans toute la vie du patient
- 1/3 formes récurrentes : avec poussées et rémissions
- 1/3 forme chronique
- Le patient présente probablement forme récurrente en poussées-rémissions vu la notion d'antécédents d'hospitalisation pour fièvre (si documenté comme une maladie de still)

**10) Donnez les armes thérapeutiques de cette maladie**

- Anti-inflammatoire
- Corticothérapie
- Immunosuppresseurs
- Biothérapie

## Cas clinique N°02 (P1 2026)

Mme A.X âgée de 43 ans consulte pour faiblesse musculaire évoluant depuis trois mois l'empêchant de se lever seule, de s'habiller et de se coiffer. Elle n'a pas d'antécédents hormis un suivi depuis quelques mois pour ménorragies et ne reçoit aucun traitement. Elle rapporte des arthralgies se réveillant la nuit touchant les poignets, coudes et les métacarpo-phalangiennes des deux mains avec difficultés à ouvrir les mains au réveil durant presque une heure. Votre interrogatoire révèle également une perte pondérale de 17 Kg en deux mois sans fièvre et l'apparition de lésions érythémateuses des paupières supérieures et d'une dysphagie.

L'examen clinique retrouve une pâleur cutanéomuqueuse, une pression artérielle est à **136/80 mm Hg**, FC à **99/mn**, FR à **22 cycles/mn**, T° **37°C**. Les mains ne sont pas déformées mais présentent un changement récent de coloration variant du bleu au blanc associées à une rougeur siégeant au niveau péri-unguéale, une adénopathie sus-claviculaire gauche ferme fixée au plan profond.

Vous constatez que votre patiente a des difficultés à se lever sans appuis sur le lit et qu'elle ne peut pas se lever de la position accroupie. La pression des masses musculaires déclenche une douleur et le testing musculaire révèle un déficit proximal. On ne note pas d'anomalies des réflexes ostéotendineux, cutané-plantaire ni de la sensibilité.

### Questions :

**1) Caractérisez les manifestations articulaires, justifiez votre réponse.**

- Rhumatisme inflammatoire chronique : survient la nuit en réveillant la patiente avec un dérouillage matinal durant environ une heure
- Touche les moyennes et petites articulations : poignets, coudes, métacarpo-phalangiennes
- Bilatéral et symétrique
- Sans déformation

**2) Les changements de coloration des mains vous font évoquer quel diagnostic ?**

- Phénomène de Raynaud

### 3) Quels éléments cliniques plaident pour son origine secondaire ?

- N'épargne pas le pouce
- Perte de caractère saisonnier
- Présence des troubles trophiques
- Douloureux
- Présence d'autres signes (extra Raynaud)

### 4) La faiblesse musculaire que présente la patiente entre dans le cadre d'un syndrome lequel ? Justifiez votre réponse.

- Syndrome myogène

#### **Justification :**

- Installation progressive
- Bilatérale et symétrique
- Touche les muscles proximaux : ceinture scapulaire et pelvienne
- Difficulté à se lever seule (signe de tabouret), de s'habiller et de se coiffer
- Absence de troubles sensitifs, réflexes ostéotendineux et cutané-plantaire sont conservés
- Myalgies spontanées ou provoquées

**NOTE : L'importance des signes négatifs :** Dans les justifications de vos cas cliniques, n'oubliez surtout pas de mentionner les **signes négatifs**. Par exemple, préciser « *l'absence de signes neurologiques (signe négatif) est en faveur d'un syndrome myogène* » est indispensable pour valider pleinement votre justification. Pensez également à bien réviser vos notions médicales de base

### 5) Afin d'affirmer ce syndrome expliquant la faiblesse musculaire, vous complétez par des paramètres biologiques lesquels ? en précisant le résultat.

- CPK : augmentées 2 fois la normale jusqu'à 20 fois la normale, un taux normal n'élimine pas le diagnostic
- Aldolase : augmenté, témoin d'une atteinte musculaire persistante (surtout si CPK normale)
- LDH (augmentée, supérieur à 280 UI/L (**normal** = [140-280])) ASAT/ ALAT : augmentées (peu utiles car peu spécifiques)

**6) Étiqueter les manifestations dermatologiques... et citer trois autres lésions dermatologiques possibles chez cette patiente en précisant le siège de celle-ci ?**

- Erythème en « V » (signe de décolleté / châte)
- Papules de Gottron (érythème ou macule violacée en regard des faces d'extension)
- Signe de manucure : érythème péri unguéal
- Erythème périorbitaire en lunettes
- Érythro-œdème lilacé des paupières

**7) La dysphagie peut être expliquée par deux mécanismes, précisez-les ?**

- Compression
- Due à la maladie elle-même avec atteinte des muscles pharyngo-laryngés

**8) A la vue des données de l'observation, comment expliquer la présence de l'adénopathie sus-claviculaire ?**

- Présence d'un syndrome paranéoplasique

**9) Quel est votre diagnostic précis ?**

- Dermatomyosite d'origine paranéoplasique

**10) Vous réalisez un bilan immunologique, citer en, au moins deux paramètres ?**

- **Anti-TIF1  $\gamma$**
- **Anti-SAE**

**11) Quels sont les principes du traitement en précisant les armes thérapeutiques ?**

- Pour la myopathie : Corticothérapie, immunosuppresseurs, immunoglobulines intraveineuses
- Syndrome de Raynaud : Protection contre le froid, éviction des produits corrosifs, éviter les bêtabloquants, et les vasoconstricteurs, éviter le tabac, Inhibiteurs calciques / Antagonistes des récepteurs de l'endothéline
- Adresser à l'oncologie pour une prise en charge de la néoplasie (éventuelle radiothérapie ou chimiothérapie)

## Cas clinique N°03 (Rattrapage 2025)

Un homme âgé de 76 ans, ayant comme antécédents une obésité, un diabète de type 2 et une hypertension artérielle, consulte pour une asthénie inhabituelle évoluant depuis 4 mois, associée à une anorexie et une sensation fébrile. Il se plaint de douleurs articulaires siégeant au niveau des épaules et des hanches, le réveillant tôt le matin et l'empêchant de se lever de son lit, avec l'impression que ses articulations sont « soudées ». À l'examen clinique, on note une limitation des mouvements des articulations douloureuses, sans autre atteinte articulaire. La tension artérielle est à **158/59 mmHg** et la température à **38 °C**.

Un traitement lui est prescrit, soulageant ses symptômes. Cependant, il revient six mois plus tard en rapportant des douleurs à la mastication ainsi que des douleurs du membre supérieur droit apparaissant à l'effort et cédant au repos.

### Bilan biologique :

Hb = **10,2 g/dL**, VGM = **76**, leucocytes = **8 900**, plaquettes = **520 000**, réticulocytes = **46 000**, test de Coombs **négatif**.

Glycémie = **2,83 g/L**, HbA1c = **9 %**,

cholestérol total = **2,6 g/L**, triglycérides = **2,1 g/L**, HDL-C = **0,3 g/L**.

VS = **170 mm**, CRP = **200 mg/L**, fibrinogène = **6 g/L**,

Facteur rhumatoïde **négatif**. Calcémie = **82 mg/L**,

Ferritinémie = **1000 (N < 200)**, gammaglobulines = **17,2**. Vitamine D **baisse**.

### Questions :

1) Caractérisez l'atteinte articulaire et justifiez.

- Rhumatisme inflammatoire chronique (réveille le malade tôt le matin avec un dérouillage matinal)
- Bilatérale et symétrique
- Sans atteinte axiale
- Atteinte des ceintures scapulaire et pelviennes

**2) Quel diagnostic rhumatologique évoquez-vous en premier ? Justifiez.**

- Pseudopolyarthrite rhizomélisque

**Justification :**

- Terrain : sujet âgé
- Douleurs articulaires inflammatoires (rhumatisme inflammatoire rhizomélisque)
- Associée à des signes généraux : asthénie, fébricule, anorexie
- Présence de syndrome inflammatoire (bilan inflammatoire positif)
- Siège au niveau de la ceinture scapulaire
- Présence d'un dérouillage matinal

**3) À quoi correspondent les nouvelles manifestations présentées par le patient ? Justifiez.**

- Manifestations ischémiques du tronc brachio-céphalique ; claudication de la mâchoire, claudication du membre supérieur
- Ischémie artérielle responsable d'ischémie musculaire donc douleur lors de la mastication et claudication de membre supérieur

**4) Quelles sont les deux causes qui peuvent expliquer ces nouvelles manifestations ?**

- Maladie de Horton
- Athérosclérose

**5) Qu'est-ce qui différencie ces deux causes cliniquement et biologiquement ? Justifiez.**

## Horton

**Clinique** : terrain évocateur + céphalées + claudication de la mâchoire + AEC + arthralgies inflammatoires

**Biologie** : CRP, VS et FIBRINOGENE élevés

### Athérosclérose :

**Clinique** : claudication membre supérieur, syndrome métabolique (diabète, dyslipidémie), absence de fièvre, AEG

**Biologie** : Pas de syndrome inflammatoire, absence de syndrome inflammatoire biologique

### 6) Interprétez le bilan inflammatoire et justifiez.

- Bilan inflammatoire positif : VS CRP FIBRINOGENE élevé, hypergammaglobulinémie, hyperferritinémie

### 7) Interprétez le bilan métabolique et justifiez.

- Diabète mal équilibré : hyperglycémie, HbA1c élevé à 9%
- Dyslipidémie : hypercholestérolémie (supérieur à 2), hypertriglycéridémie (supérieur à 1,5), HDL bas inférieur à 0,4 g/L
- Obésité
- Hypertension artérielle

### 8) Quel diagnostic retenez-vous à présent ? Justifiez.

- Maladie de Horton

**9) Quel traitement curatif donnez-vous ? Quelle est sa durée habituellement ?**

- Corticothérapie à forte dose 0.7 mg /kg/j durée : 18 à 24 mois avec dégression progressive

**10) Quelles mesures associez-vous en vue du terrain du patient ? Justifiez**

- Contrôle du diabète
- Régime hyposodé avec contrôle des apports glucidiques
- Supplémentation en vit D et en calcium
- Activité physique régulière adaptée au patient
- Surveillance de la glycémie, HTA et correction éventuelle des carences

## Cas clinique N°04 (P3 2025)

Une femme de 47 ans, aux antécédents d'appendicectomie à l'âge de 16 ans, vous a été adressée par la médecine du travail. Elle est cuisinière de formation, nouvellement recrutée dans une entreprise de pétrochimie au sud du pays. Une radiographie thoracique systématique a été réalisée retrouvant un infiltrat interstitiel bilatéral associé à un élargissement du médiastin en rapport avec des adénopathies hilaires.

L'interrogatoire retrouve une toux sèche traînante associée à une dyspnée stade 2. Elle vaque à ses occupations habituelles et ne rapporte pas de fatigue exagérée. Elle n'a pas perdu de poids et son appétit est conservé.

L'examen clinique retrouve des lésions cutanées faites de petits nodules de taille allant de 1 à 4 mm sur le visage et le bras droit, fermes, indolores et de couleur violette. La cicatrice d'appendicectomie est d'aspect chéloïde et rougeâtre depuis quelques mois. L'examen clinique ne retrouve pas de râles crépitants. Il n'y a pas d'hépatomégalie ni de splénomégalie, et les aires ganglionnaires sont libres. L'examen ophtalmologique est sans particularités. La bandelette urinaire est négative.

### Biologie :

- FNS : GB : **5200 el/mm<sup>3</sup>**, Hb : **13,9 g/dL**, VGM : **87,6fl**, CCMH : **32 g/dL**, Plaquettes : **172.000 el/mm<sup>3</sup>**, PNN : **3200 el/mm<sup>3</sup>**, lymphocytes : **800 el/mm<sup>3</sup>**, Eosinophiles : **00 el/mm<sup>3</sup>**
- Glycémie : **0.82 g/L**, Urée : **0,34 g/L**, Créatinine : **8.7 mg/L**, ASAT : **15 ui/L**, ALAT : **17 ui/L**, PAL : **42ui/l**, GGT : **37ui/l**, VS : **21 mm**, CRP : **5 mg/L**. Fibrinogène : 3,4 g/l, Calcémie : 103 mg/l
- EPP: Albumine: **42 g/l**, Alpha 1: **3,22 g/l**, Alpha 2: **5,1 g/l**, Béta-globulines: **9,7 g/l**, Gamma: **19,89 g/L**
- FAN : **négatifs**. Anti-CCP : **négatifs**, Facteur rhumatoïde : **négatif**, ANCA : **négatifs**
- Sérologie HIV, HBV, HCV, syphilis, toxoplasmose : **négatifs**
- IDR à la tuberculine : **anergique**, Quantiféron : **négatif**
- Enzyme de conversion de l'Angiotensine : **87 UI/L (20-70)**. IDR à la tuberculine : **anergique**.

### 1) Quelles sont les anomalies retrouvées à la biologie ?

- Lymphopénie (inf. à 1000)
- Hypergammaglobulinémie (sup à 15g/L)
- Elévation du taux de l'enzyme de conversion (sup à 70)

▪ Vous réalisez une biopsie cutanée. L'étude histologique conclue à des cellules épithélioïdes et des cellules géantes, entourés de lymphocytes et de fibroblastes sans nécrose caséeuses.

**2) A quoi correspond cette description ?**

- Granulome épithélio-giganto cellulaire sans nécrose caséeuse

**3) Quel diagnostic évoquez-vous ? Justifiez votre réponse**

- **Sarcoïdose systémique**

**Justifications :**

- Atteinte systémique :

Atteinte médiastino-pulmonaire : toux sèche, dyspnée stade 2, fatigue, absence de râles crépitants, à la radiographie : infiltrat interstitiel bilatérale associé à un élargissement du médiastin

Atteinte cutanée : petits nodules sur visage et bras droit fermes indolores violacés, lésions sur la cicatrice d'appendicectomie

- Signes en faveur : lymphopénie, élévation du taux de l'enzyme de conversion
- Preuve histologique : Mise en évidence de la lésion granulomateuse à la biopsie
- Elimination des autres pathologies : sérologies négatives, absence de tuberculose

**4) Quelles sont les manifestations sévères de cette maladie à rechercher systématiquement ?**

- Atteint du système nerveux central
- Atteinte cardiaque

**5) Quels sont les examens complémentaires à réaliser pour caractériser l'atteinte respiratoire que présente la patiente ? Quels sont les résultats attendus ?**

- EFR : syndrome restrictif
- Bronchoscopie pulmonaire : lymphocytose alvéolaire à prédominance de LT4
- Désaturation lors du test de marche au bout de 06 minutes
- TDM thoracique : adénopathies hilaires, bilatérales, symétriques, polycycliques, non compressives

- Après un bilan d'extension, il semble que la patiente présente une forme bénigne de la pathologie diagnostiquée.

**6) Quelle est votre attitude thérapeutique ? Justifiez**

- Traitement : plaquenil (hydroxychloroquine)
- Car la patiente présente une atteinte cutanée (sarcoïde)

- Vous recevez la patiente une année plus tard, elle signale une asthénie et une persistance de la dyspnée. L'examen clinique retrouve une splénomégalie de type 2 et des adénopathies axillaires. Les examens biologiques réalisés sont les suivants :

- FNS : GB : **4200 el/mm<sup>3</sup>**, Hb : **12,8 g/dL**, VGM : **88,6 fl**, CCMH : **33,2 g/dL**, Plaquettes : **172.000 el/mm<sup>3</sup>**, PNN : **3200 el/mm<sup>3</sup>**, lymphocytes : **650 el/mm<sup>3</sup>**.
- Glycémie : **0.82 g/L**, Urée : **0,34 g/L**, Créatinine : **11.7 mg/L**, VS : **21 mm**, CRP : **5 mg/L**.
- Fibrinogène : **3,4 g/l**, Calcémie : **113 mg/l**, Protéinurie des 24h : **950 mg**, Albuminémie : **32 g/l**, Gammaglobulinémie : **32 g/l**,
- TP : **89%**, ASAT : **119 ui/L**, ALAT : **127 ui/L**, PAL : **289ui/l (30-145)**, GGT : **289 ui/l (inf à 45)**, Bil T/D : **9/2 ui/L**.
- Enzyme de conversion : **87 UI/L (20-70)**. Sédiment urinaire : leucocyturie +++ ; ECBU : **négatif**

**7) Interprétez ses résultats : Justifiez votre réponse.**

- Lymphopénie
- Hypercalcémie modérée sup à 105 et comprise entre [115 - 125]
- Hypergammaglobulinémie sup à 15
- Elévation d'ASAT / ALAT, PAL, GGT ⇒ évoquant une cytolyse hépatique
- Protéinurie sup à 300 mg/L, ECBU négative, et leucocyturie au sédiment urinaire oriente vers atteinte rénale tubulo-interstitielle

**8) Vous pensez que ces perturbations biologiques sont en rapport avec sa pathologie. Quel traitement proposez-vous ? Justifiez**

- Corticothérapie traitement de 1<sup>ère</sup> intention : persistance des signes pulmonaires avec présence d'atteinte viscérale : hépatique, rénal,
- Correction de l'hypercalcémie : réhydratation, corticothérapie parce que c'est modéré avec surveillance de la fonction rénale, calcémie, signes cliniques

**9) Citez au moins 05 effets secondaires du traitement prescrit.**

- Hyperglycémie
- Ostéonécrose aseptique
- Hypokaliémie
- Freinage de l'axe corticotrope
- Lipolyse avec hypertriglycéridémie et hypercholestérolémie

**CT dans la page suivante :**

1 - Anomalies du bilan biologique :

\* Lymphopénie / \* Hypergammaglobulinémie / \* Enzyme de conversion (+)

2 - Biopsie cutanée:

Granulomes épithélioïdes géo-ganto-cellulaires sans nécrose caséuse

3 - Diagnostic :

\* Sarcoidose systémique / justification :

- Atteinte médiastino-pulmonaire
- Sarcome cutané
- Biologie : Lymphopénie, enzyme de conversion positive.
- Exclusion d'autres pathologies (exemple : tuberculose... ect)
- Preuve histologique

4 - Atteintes à rechercher systématiquement : (celles mentionnées dans le cours)

5 - Examen complémentaires et résultats :

- EFR ; syndrome restrictif
- Bronchoscopie pulmonaire ; (BA : (Lymphocytose alvéolaire ; Ratio CD 4/ CD8 augmenté++)
- Désaturation lors du test de marche au bout de 6 minutes
- TDM (PID, Adénopathies et caractéristiques ; élimination d'autres causes)

6 - Conduite et justification :

- Traiter (Plaquenil)
- Le sarcome cutané doit être traité

7 - Interprétation du bilan :

- \* Bilan rénal : DFG bas / Protéinurie / ECU négatif / Lymphopénie en faveur d'une atteinte tubulo-interstitielle
- \* Bilan hépatique ; cytolysé
- \* Hypercalcémie
- \* Enzyme de conversion
- \* Le reste du bilan FNS

8- Traitement et justification

- \* Correction de l'hypercalcémie
  - \* Corticothérapie
  - \* Justifiée par l'interprétation ci-dessus
- 9- Effets secondaires du traitement : (5)

## Cas clinique N°05 (P2 2025)

Une femme de 56 ans, présente des douleurs articulaires depuis 05 mois. Elle n'a pas d'antécédents, pas de fièvre et ne reçoit aucun traitement en dehors de gouttes oculaires prescrites par son ophtalmologue pour sensation de sable dans les yeux. Elle vous dit que les douleurs la réveillent la nuit et touchent les poignets, les coudes, les articulations métacarpo-phalangiennes des deux mains et les genoux. Elle vous décrit une gêne lors de l'alimentation et qu'elle a besoin de prendre des gorgées d'eau pour finir ses repas. Elle vous dit également qu'elle présente des fourmillements au niveau des plantes des pieds et remontant jusqu'aux tiers inférieurs des jambes survenant la nuit.

La bandelette urinaire : **Protéines : +, Leucocytes : +++.**

**1) Décrivez les manifestations articulaires que présente la patiente. Justifiez votre réponse.**

- Rhumatisme inflammatoire chronique (douleurs nocturnes réveillant le malade la nuit depuis 05 mois)
- Bilatérale et symétrique
- Touche les petites, moyennes, grosses articulations

**2) Quels éléments manquent afin de mieux caractériser les manifestations articulaires que présente la patiente ?**

- Présence d'un dérouillage matinal et sa durée
- Recherche de déformations
- Recherche de signes de destruction articulaire à la radiographie

**3) Quels tests demandez-vous à l'ophtalmologue ? quelle anomalie vont-ils objectiver ?**

- **Test de Schirmer** : qui va objectiver une xérophtalmie par humidification de moins de 5mm en 5 minutes
- **Temps de rupture du film lacrymal** : instillation d'une goutte de Fluorescéine et mesure du temps nécessaire à l'apparition de la première zone de rupture du film lacrymal après clignement, pathologique si inférieur à 5 secondes

#### 4) Dans ce contexte, qu'elle est l'origine des fourmillements ?

- Probablement liés à une atteinte du système nerveux périphérique : neuropathie sensitive secondaire au syndrome de Gougerot-Sjögren

#### Les examens biologiques prescrits sont les suivants :

- Hémoglobine : **13.5 g/dl**. VGM : **86 fl**. Leucocytes : **3000 elts/mm<sup>3</sup>**. Lymphocytes : **780 elts/mm<sup>3</sup>**.
- Plaquettes : **178 000 elts/mm<sup>3</sup>**. Test de Coombs négatif VS : **60 mm**. CRP : **06 mg/l**. Fibrinogènes : **3,8g/l**. Albumine : **32g/l**. Gammaglobulines : **21g/l d'aspect polyclonal**.
- Protéinurie des 24h : **1.2g**. ECBU **négatif**. Créatinine : **9mg/l**. DFG : **71 ml/min**.
- AAN : **1/1000**. Anticorps anti DNA **négatifs**, Anticorps anti-Sm **négatifs**, Anticorps Anti SSA/SSB **positifs**. Facteur rhumatoïde **positif**. Anticorps anti-CPP **négatifs**

#### 5) Interprétez l'hémogramme. Justifiez votre réponse.

- Absence d'anémie : Hb entre 12-16, VGM entre 80-100
- Leucopénie: inf à 4000
- Lymphopénie: inf à 1000
- Absence de thrombopénie : plaquettes entre 150 000 400 000

#### 6) Quel est le type de l'atteinte rénale ? justifiez votre réponse.

- Atteinte tubulo-interstitielle

**Justification :**

- Présence des leucocytes a la bandelette urinaire (leucocyturie)
- Protéinurie modérée : 1 croix et ne dépasse pas 2g (1,2g)
- Altération du DFG avec une créatinine dans les normes

**7) Quel est votre diagnostic définitif ? Justifiez votre réponse.**

- **Syndrome de Gougerot-Sjögren (primitif)**

**Justification :**

- *Terrain* : femme de 56 ans
- *Atteinte glandulaire* : xérophtalmie (sensation de sable traitée par des gouttes oculaires) et xérostomie (gène lors de l'alimentations)
- *Atteintes extra glandulaires* : neurologique : neuropathie sensitive, rénale : néphropathie tubulo-interstitielle, articulaires : polyarthralgies inflammatoires
- *Biologie* : présence d'une lymphopénie et une hypergammaglobulinémie polyclonale
- *Bilan immunologique* : Ac anti-FAN fortement positifs, Av anti SSA / SSAB positive, facteur rhumatoïde positif / Ac anti DNA SM CCP négative : absence de lupus, donc absence d'association avec autres maladies auto-immunes

**8) Quel traitement allez-vous instaurer chez la patiente ? Justifiez votre réponse.**

- Traitement spécifique : présence d'atteintes extra glandulaires (neurologique et rénale) ; corticothérapie systémique, immunosuppresseur
- Traitement symptomatique pour xérophtalmie et xérostomie : larmes artificielles, substituts salivaires, hygiène bucco-dentaire
- Surveillance ophtalmologique : risque de papillite ou vascularite rétinienne

La patiente reçoit le traitement prescrit, et les manifestations cliniques s'améliorent

Vous le recevez trois ans plus tard où elle vous rapporte un amaigrissement de 14 Kg en deux mois, une fièvre survenant surtout la nuit et une reprise des manifestations articulaires associées depuis peu de temps à une tuméfaction en regard de la mandibule droite, des adénopathies cervicales et un purpura infiltré au niveau des deux jambes.

**9) Quelle complication suspectez-vous chez la patiente compte tenu de votre diagnostic initial ? justifiez votre réponse.**

- Dégénérescence lymphomateuse

**Justification :**

- Altération de l'état générale : amaigrissement 14 kg, fièvre
- Syndrome tumoral : adénopathies cervicales
- Purpura
- Hypertrophie parotidienne

**10) Quels autres éléments cliniques et biologiques allez-vous rechercher pour étayer votre diagnostic ?**

- Eléments cliniques : la persistance d'une hypertrophie parotidienne, syndrome tumoral
- Eléments biologiques : hypergammaglobulinémie monoclonale (pic monoclonal) , Cryoglobulinémie de type 1

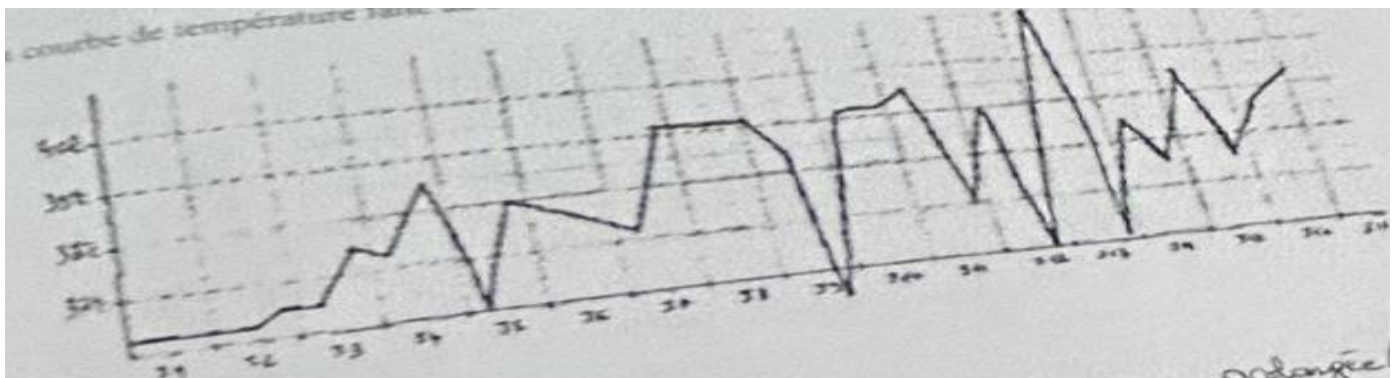
## Cas cliniques N°06 (P1 2025)

Une jeune femme de 22 ans est hospitalisée pour une fièvre associée à des douleurs articulaires depuis 04 mois. Elle n'a pas d'antécédents, et ne prend aucun traitement hormis de l'amoxicilline prescrite une dizaine de jours auparavant pour une dysphagie.

Elle vous dit que les douleurs avaient commencé au niveau des genoux mais touchent essentiellement les coudes, les poignets et les articulations métacarpo-phalangiennes des deux mains. Elles la réveillent la nuit et retrouvent ses mains comme « soudées » le matin.

L'examen clinique retrouve une pâleur cutanéomuqueuse, un gonflement des articulations douloureuses, qui sont chaudes au toucher, des adénopathies jugulo-carotidiennes bilatérales non douloureuses et mobiles à la palpation dont la plus volumineuse mesure 2 cm de diamètre. La gorge est propre et il n'existe pas de lésions buccales. Il existe une splénomégalie de type I.

La bandelette urinaire est négative. La courbe de température faite au cours de l'hospitalisation est la suivante



1) Quel type de fièvre présente la patiente ?

- Fièvre intermittente prolongée ?

2) Devant ce contexte clinique, citez les deux urgences infectieuses à rechercher en premier ?

- Endocardite
- Tuberculose

3) Citez au moins quatre cadres nosologiques pouvant expliquer le tableau clinique que présente la patiente. Donnez au moins deux exemples pour chaque cadre nosologique.

- **Maladies infectieuses** : tuberculose, endocardite
- **Maladies auto-inflammatoires** : Fièvre méditerranéenne familiale, maladie de still
- **Maladies auto-immunes** : lupus érythémateux systémique, polyarthrite rhumatoïde
- **Maladies hématologiques** : lymphome, leucémie

4) Décrivez les manifestations articulaires que présente la patiente, justifiez votre réponse.

- Rhumatisme inflammatoire chronique : douleurs articulaires depuis 04 mois, réveillant la patiente la nuit avec un dérouillage matinal (sensation des mains soudées), gonflements articulaires douloureux, chaudes
- Bilatérales et symétriques
- Migratrices touchant les grosses, moyennes et petites articulations (ayant commencé au niveau des genoux puis touchant les coudes, les poignets et les articulations métacarpo-phalangiennes)
- Sans déformation

Les examens biologiques prescrits sont les suivants :

- Hémoglobine : **9,5 g/dL**, VGM : **78 fl** ; CCMH : **30 g/dL**, réticulocytes : **8000/mm<sup>3</sup>**
- Leucocytes T : **26.600/mm<sup>3</sup>**, PNN : **20.000 mm<sup>3</sup>** ; plaquettes : **490.000/mm<sup>3</sup>**,
- ASAT : **84 UI/L**. ALAT : **97 U/L**. Test de Coombs : **négatif**
- Vitesse de sédimentation : **113 mm**, CRP : **78 mg/L**, Fibrinogène : **4,8 g/L**
- Albuminémie : **29 g/L**, Gammaglobulines : **19 g/L**, protéinurie des 24h : **280 mg**
- FAN : **négatifs**, Triglycérides : **1,2 g/L**, Cholestérol total : **1,3 g/L**

- Ferritinémie : **2X Normale**

**5) Caractérisez les anomalies retrouvées à l'hémogramme, justifiez votre réponse**

- Anémie microcytaire hypochrome arégénérative : hémoglobine inférieure à 14 g/dL(9,5), VGM inférieur à 80 fL (78), CCMH inférieur à 32 g/dL (30), réticulocytes inférieurs à 25 000 (8000)
- Non hémolytique : test de Coombs négatifs
- Hyperleucocytose à PNN : leucocytes supérieurs à 10 000 (26 600) et PNN supérieur à 7000 (20 000)
- Thrombocytose : plaquettes supérieures à 400 000/mm<sup>3</sup>

**6) Interprétez le bilan inflammatoire : justifiez votre réponse.**

- Augmentation de VS : supérieure à 16 [(Age + 10) / 2] (113)
- Augmentation de CRP : supérieure à 5 (78)
- Elévation de fibrinogène : supérieur à 4g/l
- Hypoalbuminémie : inférieur à 35g/L (29)
- Hypergammaglobulinémie supérieur à 15 (19)

Il s'agit probablement d'un syndrome inflammatoire

L'enquête étiologique que vous avez menée est négative, et aucune étiologie n'est retrouvé après une exploration exhaustive.

**7) Quel diagnostic suspectez-vous ? Justifiez votre réponse.**

- Maladie de still

**Justification :**

- **Signes cliniques** : Fièvre, arthralgies inflammatoires, dysphagie sans lésions à l'examen clinique, adénopathies non douloureuses mobiles, splénomégalie type 1
- **Biologie** : syndrome inflammatoire (augmentation de la VS, CRP, fibrinogène et des gammaglobulines, hyperleucocytose neutrophile) hyperferritinémie (2 fois la normale) cholestase anictérique (élévation ASAT, ALAT), anticorps négatifs
- **Diagnostic d'exclusion** : enquête étiologique négative (éliminer les causes infectieuses, néoplasiques, auto-immunes...)

**8) Quel élément de l'examen clinique, très spécifique pourrait vous aider à étayer votre diagnostic ? Décrivez ses caractéristiques**

- Éruption cutanée : rash saumoné évanescent

**Les caractéristiques :**

- Maculo-papuleaux
- Rose saumon
- Souvent discret
- Non prurigineuse
- Évanescent : apparaît pendant les pics fébriles et disparaît en quelques heures
- Peut être induit par la pression ou le grattage (phénomène de Koebner-Like)

Le médecin de garde retrouve cet élément clinique, rendant votre diagnostic très probable

**9) Quel traitement de première intention indiquez-vous chez la patiente ?**

- Corticothérapie : 1mg/kg/j (y a une atteinte viscérale si non on prescrit les anti inflammatoire)

La patiente débute le traitement et l'apyrexie est obtenue dans les 48h suivantes.

Néanmoins, au troisième jour, la fièvre réapparaît et l'état général de la patiente s'altère.

Le bilan biologique réalisé est le suivant :

- Hémoglobine : **7,2 g/dL**, VGM : **78 fl**, CCMH : **30 g/dL**, leucocytes : **15.600/mm<sup>3</sup>**, Plaquettes : **90.000 /mm<sup>3</sup>**. Test de Coombs **négatif**.
- ASAT : **132 UI/L**. ALAT : **146 UI/L**.
- Vitesse de sédimentation : **132 mm**, CRP : **192 mg/L**, fibrinogène : **6,9 g/L**,
- Albuminémie : **22 g/L**. Gammaglobulines : **19 g/L**, protéinurie des 24h : **280 mg**,
- Triglycérides : **3,8 g/L**, Cholestérol total : **1,3 g/L**, Ferritinémie : **18X normale**.

**10) Quelle complication de sa pathologie craignez-vous ? Justifiez votre réponse**

- Syndrome d'activation macrophagique

**Justifications :**

- Clinique : réapparition de la fièvre, altération de l'état général
- Biologique : cytopénie (anémie, thrombopénie, diminution des leucocytes de 20 000 à 15 600), augmentation de la VS et CRP, fibrinogène (de 4,8 à 6,9), hypertriglycérémie, cytolysé hépatique (augmentation des ASAT et des ALAT presque 3 fois la normale), hyperferritinémie (18 fois la normale)

## CAS CLINIQUE N° 07 (P1 2024)

Une jeune femme de 25 ans consulte pour douleurs articulaires évoluant depuis 3 mois.

Elle n'a pas d'ATCD, pas de fièvre et ne reçoit aucun traitement en dehors d'une pilule œstroprogestative.

Actuellement ses arthralgies la réveillent la nuit et touchent les poignets et les métacarpo-phalangiennes des 2 mains l'empêchant d'ouvrir les mains au réveil.

### Votre interrogatoire relève :

- La survenue de lésions érythémateuses du visage l'été précédent
- L'apparition des arthralgies qui n'ont laissé aucune cicatrice.
- Elle présente également une douleur basithoracique gauche aggravée par l'inspiration.

### L'examen clinique retrouve :

- PA = **156/92** mm Hg
- Les mains ne sont pas déformées mais présentent un changement récent de coloration variant du bleu au blanc.
- Des œdèmes des membres inférieurs
- Une matité et une abolition du murmure vésiculaire de la base pulmonaire gauche.
- BU : **Protéines** +++ / **Sang** +

### 1) Caractérisez les manifestations articulaires, justifiez votre réponse : 3points

- Rhumatisme articulaire inflammatoire (survient la nuit) chronique des moyennes et petites articulations **acromélique** touchant les moyennes et les petites articulations
- Bilatérale et symétrique (touche les 2 mains)
- Avec un dérouillage matinal sans déformation
- A priori sana atteinte axiale

2) Les changements de colorations des mains vous font évoquer quel diagnostic ? Quels éléments cliniques plaident pour son origine secondaire ?

- Phénomène de Raynaud secondaire

**Éléments de l'origine secondaires :**

- Présence d'autres manifestations : rhumatisme inflammatoire, la photosensibilité, atteinte rénale probablement glomérulaire

3) Compte tenu du contexte, quel sont les caractéristiques cliniques des œdèmes de MI :  
0 3 Points

- Sont secondaires au syndrome néphrotique
- Blanc, mous, prenant le godet

**Justification :**

- Il s'agit probablement d'un syndrome glomérulaire vu la présence d'une hématurie, protéinurie, hypertension artérielle

4) Il existe un épanchement pleural, quelle sont les caractéristiques biologiques (biochimique et cytologique) du liquide pleural ? Justifiez votre réponse :

- Biochimique : exsudatif riche en protéines  $\Rightarrow$  origine inflammatoire
- Cytologique : lymphocytaire

5) Citez au moins trois autres lésions dermatologiques à rechercher :

- Érythème malaire
- Lupus subaigue
- Lésion au niveau des mains

**Les examens biologiques prescrits sont les suivants :**

- Hb : **9.5** g/dl ; VGM : **105** fl. ; leucocytes : **3500**/mm<sup>3</sup>. Plqt : **70000**/mm<sup>3</sup> ; réticulocytes : **179000**/mm<sup>3</sup>
- Bilirubine directe : **4** mg/l / ASAT : **25**UI/l / ALAT : **30**UI/l.
- Test de Coombs **positif** ; Vitesse de sédimentation : **60** mm / CRP : **10** mg/l.
- Fibrinogène : **4.8** g/l / taux de protides : **54** g/l / Alb : **23** g/l. Gammaglobulines : **5** g/l
- PU des 24h : **4** g
- Ac anti-nucléaires à **1/640**
- Ac anti-DNA positifs ; AC anti-Sm positifs.

**6) Caractérisez les anomalies retrouvées à l'hémogramme, justifiez votre réponse : 03points**

- Anémie (inférieur à 14) hémolytique auto-immune (test de Coombs positif) a tendance macrocytaire (VGM supérieur à 100 (105)) régénérative (taux de réticulocytes sup a 120000)
- Leucopénie inf a 4000
- Thrombopénie inf a 150000

**7) Quelle est le type de l'atteinte rénale ? justifiez votre réponse :**

- Atteinte glomérulaire
- Syndrome néphrotique impur : taux de protide inférieur à 60 ALB inférieur à 30 protéinurie supérieure à 3g et hypogammaglobulinémie inférieure à 8, impur = Hta et hématurie

**8) Quel est votre diagnostic définitif ? justifiez votre réponse :**

- Lupus érythémateux systémique

**Justification :**

- Terrain femme jeune de 25 ans
- Manifestation cutanée : lésions érythémateuses du visage, phénomène de Raynaud
- Manifestations articulaires : arthralgies inflammatoires chroniques
- Manifestations rénales : atteinte glomérulaire, syndrome néphrotique
- Manifestation pulmonaire : pleurésie (douleur basithoracique gauche aggravée à l'inspiration)
- Bilan immunologique : FAN fortement positifs, Anticorps anti DNA positifs, Anticorps anti-Sm positifs

Les examens patiente a reçu un traitement spécifique qui a permis l'amélioration clinique et la négativation des anomalies biologiques.

Elle consulte chez vous un an au plus tard pour une grosse jambe douloureuse, faisant diagnostiquer une thrombose poplitée droite. Elle vous apprend également qu'elle a présenté il y a deux mois une mort in utéro à 24 semaines d'aménorrhée. Un bilan immunologique retrouve :

- Des AC anti-B2GP1 positifs
- Des AC anti-Cardiolipine positifs.

**9) Quel diagnostic évoquez-vous ? justifiez votre réponse :**

- SAPL secondaire associé au lupus

**Justification :**

- Association fréquente avec lupus
- Manifestation thrombotique : thrombose poplitée droite
- Manifestation obstétricale : mort in utéro à 24 semaines d'aménorrhée
- Bilan immunologique : ac anti-B2GP1 positifs et ac anti-cardiolipine positifs

**10) Quelles sont les 2 anomalies de bilan d'hémostase qui peuvent être observées dans ce contexte :**

- Thrombopénie
- Allongement du TCA

**11) En plus du traitement médicamenteux, quels sont les conseils que vous prodiguez à votre patiente afin d'éviter les rechutes :**

- Contraception adaptée
- Planification des grossesses

## CAS CLINIQUE N° 08 (P2 2024)

Un homme de 72 ans, sans antécédents hormis une HTA révélée par des céphalées occipitales et un diabète de type 2 bien équilibrés sous traitement, consulte pour une fatigue inhabituelle associée à une sensation fébrile et une anorexie évoluant depuis environ 03 mois.

Il vous rapporte également des douleurs au niveau des articulations des épaules et des hanches, le réveillant très tôt le matin et l'empêchant de se lever du lit, comme si ses articulations étaient « soudées ». L'examen clinique est sans particularité hormis une limitation des mouvements des articulations douloureuses. Il n'existe aucune autre plainte articulaire.

La pression artérielle est à **138/62** mm Hg au bras droit et à **135/60** au bras gauche, la température à **38,2°**

### 1) Caractérisez les manifestations articulaires, justifiez votre réponse

- Rhumatisme inflammatoire chronique (réveillant très tôt le matin, dérouillage matinal)
- Atteinte des ceintures scapulaires et pelviennes
- Sans atteinte axiale
- Bilatérale et symétrique

### 2) Quel diagnostic rhumatologique évoquez-vous en premier ? justifiez votre réponse

- Pseudopolyarthrite rhizomélisque

#### **Justification**

- Terrain ; sujet âgé
- Douleurs articulaires inflammatoires touchant les ceintures scapulaires et pelviennes
- Présence de signes généraux : fièvre, anorexie, asthénie

Ce patient reçoit un traitement qui permet de soulager ses symptômes. Il revient vous voir six mois plus tard pour la réapparition des mêmes symptômes associés à des céphalées temporo-pariétales depuis une semaine qui ne cèdent pas après prise de paracétamol

**3) Compte tenu du contexte, quel diagnostic suspectez-vous ? justifiez votre réponse**

- Maladie d'Horton

**Justifications :**

- Terrain : sujet âgé
- Céphalées temporo-pariétales d'apparition récente, non soulagées par la prise de paracétamol (rebelle aux antalgiques)
- Altération de l'état général : fièvre, asthénie, anorexie
- Rhumatisme inflammatoire

**4) Citez au moins trois anomalies cliniques anamnestiques que vous recherchez pour étayer votre diagnostic ?**

- Baisse brutale de l'acuité visuelle ou flou visuel
- Claudication intermittente de la mâchoire
- Hyperesthésie du cuir chevelu (signe du peigne)

**5) Citez au moins trois anomalies recherchées à l'examen physique pour étayer votre diagnostic**

- Anomalie de la palpation de l'artère temporale (indurée, sensible, abolition ou diminution du pouls temporal)
- Asymétrie tensionnelle entre les deux bras
- Nécrose du cuir chevelu

Le patient ramène avec lui un bilan biologique prescrit par son médecin de famille qui est le suivant :

- Hémoglobine ; **9,7 g/dl** ; VGM : **76 fl** ; leucocytes : **8900/mm<sup>3</sup>** ;
- Plaquettes : **460 000/mm<sup>3</sup>** ; Réticulocytes : **46 000/mm<sup>3</sup>** ; test de Coombs **Négatifs**

- Vitesse de sédimentation : **126** mm ; CRP : **132** mg/l ; fibrinogène : **6,1** g/l
- Gammaglobulines à **17,2** g/l, Ferritinémie **1270** µg/l (N inf à 280)
- Facteur rhumatoïde négatif

**6) Interprétez le bilan inflammatoire (justifiez votre réponse)**

- Augmentation de la VS et de la CRP (supérieur à 5mg/L)
- Elévation du taux de fibrinogène (supérieur à 4 g/L)
- Hypergammaglobulinémie : supérieure à 15 g/L

Vous décidez de demander d'autre examens pour confirmer votre suspicion diagnostique

**7) Que préconisez-vous en attendant les résultats ? justifiez votre réponse**

- Instaurer une corticothérapie : 0,7 mg/Kg/j
- Suivi clinique et biologique régulier

Le patient est perdu de vue, puis est amené aux urgences deux semaines plus tard pour une baisse brutale de l'acuité visuel des deux yeux

**8) Quelles sont les trois atteintes ophtalmologiques possibles dans ce contexte ?**

- Diplopie
- Neuropathie optique ischémique antérieure NOIA
- Cécité

Le patient est hospitalisé et un traitement est débuté en urgence

L'examen clinique retrouve une abolition du pouls huméral droit, la pression artérielle est à **92/43** mm Hg au bras droit et à **148/67** au bras gauche

9) Interprétez les résultats de la prise de la pression artérielle (justifiez votre réponse)

- Asymétrie tensionnelle entre les deux bras, supérieure à 20 mm Hg

10) À quoi sont dues les anomalies vasculaires observées chez le patient ?

- Probablement dues à une sténose voire une occlusion artérielle de l'artère sous-clavière droite

11) Le traitement prescrit expose le patient à des effets secondaires, citez-en au moins quatre

- Hyperglycémie
- Ostéonécrose aseptique
- Hypokaliémie
- Freinage de l'axe corticotrope

## CAS CLINIQUE N° 09 (P2 2024)

Mr H.A âgé de 24 ans consulte pour une grosse jambe douloureuse gauche

ATCD : psoriasis chez la sœur et son frère est suivi pour panuvéite bilatérale

EXAMEN CLINIQUE : diminution du ballonnement du mollet gauche, œil rouge avec baisse de l'acuité visuelle révélant une vascularite rétinienne au FO

PA :124/82 ; FC :90 ; FR :18 ; T° :37,8

**1) Vous évoquez un diagnostic, lequel ? justifiez**

- Maladie de Behçet

### **Justification :**

- Terrain : homme jeune
- ATCD familiaux de maladies auto-immunes
- Présence d'une atteinte ophtalmologique : vascularite rétinienne avec antécédent de panuvéite chez le frère
- Présence d'une atteinte vasculaire : thrombose veineuse profonde unilatérale au niveau de la jambe gauche

**2) Citez 5 manifestations cutanéomuqueuses à rechercher chez ce patient**

- Aphtose buccale
- Aphtose génitale
- Erythème noueux
- Pseudofolliculite
- Ulcérations cutanées

### 3) Quelles sont les caractéristiques de l'atteinte vasculaire au cours de cette maladie

- Siège banal ou inhabituelle
- Atteinte de vaisseaux de tous calibres
- Bilatérale
- Récidive
- Sans facteurs de risque vasculaire

#### BIOLOGIE :

- GB : **12000** ; HB : **14** ; PLQTT : **200000** ; PNN : **8000** ;
- CRP : **64** ; VS : **80** ; FIBRINOGENE : **5**

### 4) Interprétez le bilan, donnez le diagnostic biologique et les situations cliniques associées à celui-ci au cours de la pathologie évoquée

- Taux de plaquettes, hémoglobine PNN sans anomalie
- Légère hyperleucocytose à neutrophiles
- Augmentation de la VS, CRP, fibrinogène
- Donc il s'agit probablement d'un syndrome inflammatoire

Les situations cliniques associées à un syndrome inflammatoire sont

- Angio Behçet, Neuro, entero behçet, Érythème noueux, atteinte articulaire

Au cours de son hospitalisation, la patiente rapporte une toux rarement des crachats hémoptoïques

### 5) Vous évoquez 2 diagnostics lesquels

- Anévrisme de l'artère pulmonaire
- Embolie pulmonaire

**6) Vous décidez de mettre un traitement, citez les armes thérapeutiques**

- AINS : Colchicine
- Corticoïdes
- Immunosuppresseurs
- Biothérapie

Après une bonne évolution, le patient reconsulte après 2 ans pour céphalées intenses évoluant depuis 5 jours rebelles au traitement antalgique habituel, il décrit des nausées et vomissements ainsi qu'une vision double depuis 3 jours

Il est apyrétique confus sans syndrome méningé, on note une aphtose buccale et un œdème papillaire bilatéral à l'examen ophtalmologique

**7) Cette présentation évoque un syndrome lequel ?**

- Syndrome d'hypertension intracrânienne

**8) Vous évoquez 2 diagnostics, lesquels ?**

- Rupture d'anévrisme cérébral
- Thrombose veineuse cérébrale

**9) Quel est l'examen demandé en 1ère intention afin d'étayer le diagnostic**

- Angio IRM cérébrale

**10) Citez 3 complications pouvant engendrer le pronostic visuel**

- Uvéite postérieure
- Œdème papillaire
- Vascularite rétinienne